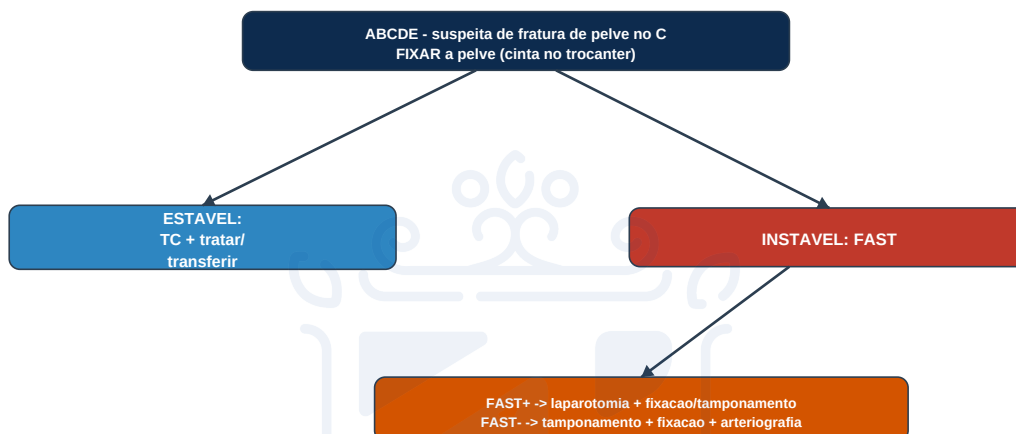


## TRAUMA DE PELVE — FIXAR E ESTANCAR

### FLUXOGRAMA — SUSPEITA À CONDUTA

#### PELVE — FIXAR CEDO, FAST DECIDE



### DEFINIÇÃO

#### O QUE É

- Trauma contuso de ALTA energia, associado a múltiplas lesões e ALTA mortalidade
- A pelve sangra muito — pode coletar TODA a volemia (sangramento oculto)
- Manejo inicial = ABCDE; na etapa C: fixação da pelve + reanimação volêmica + hipotensão permissiva + PTM, REBOA se disponível
- Sangramento: 90% VENOSO (fraturas ósseas/plexo) e 10% arterial (pudenda interna, glútea superior, sacral lateral, íliaca interna)

### QUANDO SUSPEITAR E COMO EXAMINAR

#### AValiação (UMA VEZ SÓ!)

- Suspeitar: crepitação, dor à mobilização, deformidades, hematomas, membro encurtado/rodado
- Inspeção: deformidade, rotação, encurtamento; Palpação: sínfise púbica, mobilização AP e súpero-inferior
- Se UMA única alteração ou dor -> FIXAR a pelve
- NÃO mobilizar de novo! (re-mobilizar desfaz o coágulo e PIORA o sangramento)
- Sempre buscar lesões associadas (abdome, urogenital, perineal)

### IMOBILIZAÇÃO — FIXAÇÃO TEMPORÁRIA

#### Rx FECHAR A PELVE (TAMPONAR O SANGRAMENTO)

Objetivo: reduzir o volume pélvico e estancar momentaneamente o sangramento (efeito tamponamento)

Dispositivo: lençol, faixa, cinta ou dispositivo próprio (cinta pélvica)

Posicionar ao nível do TROCANTER MAIOR (não na crista ilíaca)

Comprimir bem; deixar o ABDOME LIVRE (para eventual laparotomia)

Reanimação volêmica balanceada + protocolo de transfusão maciça + hipotensão permissiva

## ESTÁVEL x INSTÁVEL

| Situação                 | Conduta                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estável                  | TC computadorizada; tratar e transferir conforme necessidade                                                                                      |
| Instável + FAST positivo | Trauma pélvico E abdominal: laparotomia supraumbilical + tamponamento extraperitoneal + fixação externa + arteriografia/embolização se necessário |
| Instável + FAST negativo | Trauma pélvico: tamponamento extraperitoneal + fixação externa + arteriografia/embolização se necessário                                          |

## TIPOS DE FRATURA (anel pélvico)

| Tipo                               | Mecanismo                                           | Sangramento                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| A - Lateral (compressão)           | Colisões automobilísticas; rotação medial do anel   | Sangra MENOS, lesiona mais estruturas |
| B - Anteroposterior (livro aberto) | Atropelamento, trauma importante                    | Sangramento IMPORTANTE                |
| C - Cisalhamento vertical          | Queda/trauma unilateral; rotura ligamentar complexa | GRANDE sangramento                    |

## INTERVENÇÕES DEFINITIVAS

### FIXAÇÃO EXTERNA / TEP / ARTERIOGRAFIA

- Fixação externa: reduz o volume pélvico, diminui o sangramento e evita lesões adicionais
- Tamponamento extraperitoneal (TEP): controle do sangramento venoso (a maioria)
- Alguns protocolos iniciam pela fixação externa isolada e reavaliam a indicação de TEP
- Arteriografia + embolização: nova piora clínica OU não melhora com alto risco de sangramento (10% arterial)
- Trauma pelvipérineal complexo (fratura + comunicação com meio externo cutâneo/urogenital/anorretal): manejo ABCDE + multidisciplinar

## MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

### RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Trauma pélvico de alta energia (mecanismo \_\_\_\_); tipo provável \_\_\_\_ (lateral/livro aberto/vertical).
- Pelve FIXADA (cinta no trocanter): sim/não; estabilidade: \_\_\_\_; FAST: positivo/negativo.
- Reanimação + transfusão maciça \_\_\_\_; tamponamento/fixação externa/arteriografia: \_\_\_\_.
- Solicito centro com cirurgia/ortopedia/radiologia intervencionista (estabilizar antes de transferir).

## FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

### QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Vítima de atropelamento, instável, com dor e instabilidade à palpação da pelve. Qual a primeira medida específica na etapa C?

- A) Mobilizar repetidamente a pelve para caracterizar a fratura
- B) Fixar a pelve com cinta ao nível do trocanter maior (reduz volume e sangramento)
- C) Solicitar tomografia antes de qualquer medida
- D) Aguardar a arteriografia
- E) Aplicar a cinta na crista ilíaca

### QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é a principal origem do sangramento na fratura de pelve?

- A) Arterial (90%)
- B) Venoso e ósseo (cerca de 90%)
- C) Apenas artéria ilíaca externa
- D) Lesão de víscera oca
- E) Sangramento digestivo

### QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Por que NÃO se deve mobilizar repetidamente a pelve após identificar instabilidade?

- A) Por dor apenas
- B) Porque a re-mobilização desfaz o coágulo e piora o sangramento
- C) Porque atrasa a tomografia
- D) Porque não altera a conduta
- E) Porque mascara fraturas de fêmur

### QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Paciente com trauma de pelve instável e FAST negativo. Conduta?

- A) Laparotomia exploradora de imediato
- B) Tamponamento extraperitoneal + fixação externa + arteriografia/embolização se necessário
- C) Apenas observação
- D) Alta com analgésico
- E) Somente tomografia

### QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual fratura de pelve cursa com maior sangramento?

- A) Compressão lateral (tipo A)
- B) Anteroposterior 'livro aberto' (tipo B) e cisalhamento vertical (tipo C)
- C) Fraturas de cóccix isoladas
- D) Fraturas sem desvio
- E) Nenhuma sangra de forma significativa

## GABARITO COMENTADO

### QUESTÃO 1 → Resposta: B

Diante de instabilidade/dor pélvica no paciente instável, a primeira medida é fixar a pelve com cinta ao nível do trocanter maior, reduzindo o volume pélvico e tamponando o sangramento. Não se mobiliza repetidamente.

### QUESTÃO 2 → Resposta: B

Cerca de 90% do sangramento da fratura de pelve é venoso/ósseo (fraturas e plexo venoso); apenas ~10% é arterial — o que justifica priorizar fixação/tamponamento, reservando a arteriografia/embolização para casos selecionados.

### QUESTÃO 3 → Resposta: B

Re-mobilizar a pelve instável desfaz o coágulo formado e agrava o sangramento. Após uma avaliação que identifique alteração/dor, fixa-se e NÃO se mobiliza novamente.

### QUESTÃO 4 → Resposta: B

Trauma pélvico instável com FAST negativo (sangramento pélvico, não abdominal): tamponamento extraperitoneal + fixação externa + arteriografia/embolização se necessário. FAST positivo associaria laparotomia.

### QUESTÃO 5 → Resposta: B

As fraturas anteroposteriores ('livro aberto', tipo B) e por cisalhamento vertical (tipo C) cursam com maior sangramento; a compressão lateral (tipo A) sangra menos, porém lesiona mais estruturas internas.

SM24  
Suporte ao Plantão Médico